

- 139★★★ 閉塞性睡眠時無呼吸症候群 (OSAS) は喘息の悪化、増悪因子ではない。
✓✓✓
- 140★★★ 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 (eosinophilic granulomatosis with polyangiitis: EGPA) には喘息の発症が先行することが多い。
✓✓✓
- 141★★★ アレルギー性気管支肺真菌症では末梢血好酸球増多、血清総 IgE 高値、真菌特異的 IgE 抗体陽性となる。
✓✓✓
- 142★★★ 咳喘息は咳だけを症状とする喘息の亜型である。
✓✓✓
- 143★★★ 咳喘息は慢性咳嗽の最多の原因疾患である。
✓✓✓
- 144★★★ 咳喘息の多くは湿性咳嗽である。
✓✓✓
- 145★★★ 咳喘息は深夜や早朝に悪化しやすい。
✓✓✓
- 146★★★ 咳喘息では外因性抗原への感作が約 60% の患者にみられる。
✓✓✓
- 147★★★ 咳喘息ではアレルギー性鼻炎の合併が約 50% の患者にみられる。
✓✓✓
- 148★★★ 咳喘息の患者では咳受容体感受性の低下がみられる。
✓✓✓
- 149★★★ 咳喘息では気管支拡張薬が有効であることで診断できる。
✓✓✓
- 150★★★ 咳喘息の軽症例では中用量の ICS で加療する。
✓✓✓
- 151★★★ 咳喘息の中等症以上では、ICS/LABA が治療の中心となる。
✓✓✓
- 152★★★ 咳喘息は高頻度で胃食道逆流症 (gastro esophageal reflux disease: GERD) による慢性咳嗽を合併する。
✓✓✓
- 153★★★ 咳喘息に ICS を使用しても、典型的な喘息への移行を防ぐことはできない。
✓✓✓
- 154★★★ 咳喘息では薬剤の中止後に症状が再燃することはない。
✓✓✓